Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
Coordenação-Geral de Promoção da Alimentação Saudável

NOTA TÉCNICA Nº 65/2025

PROCESSO Nº 71000.091375/2025-85

1. ASSUNTO

1.1. Subsídios técnicos para apoio à regulamentação local da promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, conforme o Decreto nº 11.821/2023.

2. ANÁLISE

2.1. Introdução

2.1.1. A escola é um espaço privilegiado para a formação de valores, conhecimentos e práticas que moldam o presente e o futuro de crianças e adolescentes. Nesse contexto, o ambiente alimentar escolar tem papel central, sendo responsável por até 50% da ingestão diária de alimentos dos estudantes. Por isso, sua influência é decisiva na promoção da segurança alimentar e nutricional, na prevenção de doenças e na promoção da saúde, além de ser fundamental para o desenvolvimento cognitivo, o desempenho acadêmico, o comportamento e o bem-estar dos alunos[1, 2]. No entanto, o cenário atual é preocupante: observa-se a crescente presença de alimentos ultraprocessados nas escolas brasileiras, especialmente nas instituições privadas, onde os mecanismos de regulação e fiscalização são mais frágeis[3, 4].

2.1.2. Os alimentos ultraprocessados (formulações industriais compostas majoritariamente por substâncias extraídas de alimentos ou sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, emulsificantes e outros aditivos) são pobres em nutrientes e ricos em açúcares, gorduras não saudáveis e sódio[5-8]. Seu consumo tem sido amplamente associado ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como obesidade, diabetes, hipertensão e câncer. A exposição precoce e contínua a esses alimentos compromete o desenvolvimento saudável e perpetua desigualdades[7-11].

2.1.3. O crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente ligado à expansão de sistemas alimentares baseados em monoculturas e commodities, que reduzem a oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, comprometem a soberania alimentar, a biodiversidade e o meio ambiente. Esse modelo de produção e consumo, além de impactar negativamente a saúde humana, também agrava a crise climática e a degradação dos ecossistemas[12-16].

2.1.4. Importante destacar que a alimentação não é apenas resultado de escolhas individuais, mas fortemente influenciada pelos ambientes em que as pessoas vivem, estudam e trabalham. Por isso, é fundamental que esses espaços sejam estruturados para apoiar escolhas mais saudáveis, por meio de políticas públicas, regulamentações e ações intersetoriais que promovam ambientes alimentares mais justos e protetores [17, 18].

2.1.5. Diante desse cenário, o Governo Federal publicou o Decreto nº 11.821, de 12 de dezembro de 2023 (doravante denominado “Decreto”), que estabelece diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, considerado um espaço estratégico para a garantia da segurança alimentar e nutricional e para a formação de hábitos alimentares[19]. A elaboração da normativa foi liderada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à

Fome (MDS), em articulação com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. O objetivo foi fortalecer o papel educativo e protetivo das escolas, especialmente na infância e adolescência. O Decreto prioriza a oferta de alimentos in natura ou minimamente processados nas escolas, em consonância com os Guias Alimentares brasileiros[5, 6], que recomendam evitar o consumo de alimentos ultraprocessados em todas as faixas etárias. A normativa orienta a atuação dos entes federativos em três eixos fundamentais: educação alimentar e nutricional; comercialização e doação de alimentos; e comunicação mercadológica.

2.2. **Contexto epidemiológico e nutricional da população brasileira**

2.2.1. O Brasil enfrenta um quadro de insegurança alimentar e nutricional, marcado pela coexistência de desnutrição, deficiências nutricionais e excesso de peso[20-24]. O excesso de peso e a obesidade seguem em trajetória ascendente: segundo o Vigitel 2023, 61,4% das pessoas com 18 anos ou mais, residentes nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, apresentavam excesso de peso, e 24,3% tinham obesidade[25].

2.2.2. Entre crianças e adolescentes brasileiros, a prevalência de obesidade tem crescido de forma expressiva nas últimas décadas. De acordo com estimativas internacionais, a taxa de obesidade entre meninas de 5 a 19 anos aumentou de 3,1% em 1990 para 14,3% em 2022, enquanto entre meninos passou de 3,1% para 17,1% no mesmo período[26]. O Brasil ocupava, em 2022, a 54ª posição no ranking global de obesidade infantil e adolescente. Projeções indicam que, mantidas as tendências atuais, mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros poderá apresentar excesso de peso até 2035. Estima-se ainda que uma em cada três crianças no País já esteja com sobrepeso, com um crescimento anual projetado de 1,8% no número de crianças com índice de massa corporal para idade elevado entre 2020 e 2035[27]. Esses dados reforçam a urgência de políticas públicas voltadas à prevenção da obesidade desde a infância, com foco na promoção de ambientes alimentares saudáveis, especialmente no contexto escolar.

2.2.3. Além de configurarem condições crônicas em si, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, cânceres e outras DCNT[28-31], que hoje são responsáveis por mais da metade das mortes anuais no País[32].

2.3. **Impactos do consumo de alimentos ultraprocessados**

2.3.1. O consumo de alimentos ultraprocessados tem crescido de forma significativa no Brasil nas últimas décadas. Entre 2002-2003 e 2017-2018, a contribuição calórica dos ultraprocessados na disponibilidade domiciliar de alimentos aumentou de 12,6% para 18,4%. Nas regiões metropolitanas, esse percentual passou de 10% para 24%[33]. O consumo pessoal também se intensificou, sobretudo entre populações em situação de vulnerabilidade, refletindo mudanças nos padrões alimentares da população[34].

2.3.2. Esse cenário é particularmente preocupante na infância. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019)[35] revelou que os ultraprocessados representaram, em média, 24,7% das calorias consumidas por crianças menores de cinco anos, com crescimento acentuado conforme a idade: 3,3% entre crianças de 0 a 5 meses, 20,5% entre 6 a 23 meses e 30,4% entre 24 a 59 meses. Os itens mais consumidos incluem biscoitos doces, farinhas infantis, chocolates, sobremesas industrializadas e bebidas lácteas. Além da elevada participação desses produtos na alimentação infantil, o estudo evidenciou desigualdades marcantes: o consumo foi maior nas regiões Nordeste (27,3%) e Sul (25,2%), e menor no Norte (21,7%); crianças residentes em áreas urbanas consumiram mais alimentos ultraprocessados (24,8%) do que aquelas em áreas rurais (21,0%); e crianças pretas apresentaram maior participação de energia proveniente de ultraprocessados (26,6%) do que crianças pardas (24,9%) e brancas (24,0%). Esses achados reforçam a urgência de políticas públicas que enfrentem as desigualdades alimentares desde a primeira infância, com ações intersetoriais voltadas à regulação da oferta, à educação alimentar e à proteção social.

2.3.3. Dados mais recentes do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN, 2023) reforçam esse panorama: mais de 80% das crianças acompanhadas pelo Programa Bolsa Família

consumiram ao menos um alimento ultraprocessado no dia anterior, sendo os mais frequentes biscoitos recheados, bebidas adoçadas e salgadinhos de pacote[36].

2.3.4. O consumo de alimentos ultraprocessados é um dos principais determinantes do aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Metanálises recentes identificaram mais de 30 desfechos negativos de saúde relacionados a padrões alimentares com alta presença desses produtos, incluindo maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer colorretal, depressão e mortalidade precoce [9-11, 37, 38].

2.3.5. No Brasil, estima-se que 30% do aumento da obesidade entre 2002 e 2009 esteja relacionado ao crescimento do consumo desses alimentos[39]. Em 2019, cerca de 10,5% das mortes prematuras entre adultos de 30 a 69 anos (aproximadamente 57 mil óbitos)[40] e 22% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares foram atribuídas aos ultraprocessados[41]. Em estudos com crianças e adolescentes já se observam associações com cárie dentária[42], obesidade e dislipidemias[43].

2.3.6. Além dos impactos sociais e à saúde, os alimentos ultraprocessados contribuem para a degradação ambiental, a perda da biodiversidade e o aumento das emissões de gases de efeito estufa, devido à sua dependência de sistemas alimentares baseados em monoculturas e cadeias industriais intensivas[5, 13, 44-47].

2.4. **Fundamentação legal**

2.4.1. A promoção de ambientes alimentares escolares saudáveis está respaldada por um conjunto robusto de dispositivos legais e normativos, que reconhecem a alimentação como um direito humano fundamental e um dever do Estado:

- 2.4.2. Constituição Federal (1988) – Artigos 6º, 208 e 227 garantem o direito à saúde, à alimentação e à proteção integral da criança e do adolescente[48];
- 2.4.3. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) – Reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e assegura prioridade absoluta à sua proteção e desenvolvimento[4];
- 2.4.4. Lei nº 11.947/2009 – Garante a alimentação escolar como direito dos alunos da rede pública de educação básica[50];
- 2.4.5. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) – Proíbe publicidade enganosa ou abusiva, especialmente quando dirigida ao público infantil[51];
- 2.4.6. Resolução nº 163/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) – Define como abusiva toda comunicação mercadológica dirigida à criança[52];
- 2.4.7. Lei nº 13.666/2018 – Inclui a educação alimentar e nutricional como tema transversal no currículo escolar[53].

2.4.8. Além disso, o Decreto está alinhado a compromissos internacionais e nacionais assumidos pelo Brasil, que reforçam a urgência de ações para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar.

2.4.9. No âmbito internacional, destaca-se a adesão do País aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente os ODS 2 (acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, e promover a agricultura sustentável), ODS 3 (assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades), ODS 6 (assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos) e ODS 12

(assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis)[54]. O Brasil também é signatário da Década de Ação pela Nutrição (2016-2025)[55], sendo o primeiro país a assumir compromissos específicos no âmbito dessa iniciativa da ONU, e participou ativamente da Cúpula de Sistemas Alimentares (UNFSS+2) [56], reafirmando seu compromisso com a transformação dos sistemas alimentares em direção à sustentabilidade e equidade.

2.4.10. No plano nacional, o Decreto está em consonância com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2025-2027) [57], que integra a agenda estratégica do Governo Federal para garantir o direito humano à alimentação adequada, e com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030[31], que estabelece metas e estratégias intersetoriais para enfrentar os principais fatores de risco relacionados às DCNT, como os padrões alimentares inadequados. Soma-se a esses instrumentos o compromisso do MDS, que, por meio de seu Planejamento Estratégico Institucional para o período de 2023 a 2026, estabelece como meta a publicação e implementação, em parceria com o Ministério da Educação, de diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar nas 27 unidades federativas até 2026[58]. Além disso, o MDS participa do Acordo de Cooperação Interministerial para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, que prevê a elaboração da diretriz nacional para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, em articulação com diferentes órgãos do Governo Federal[59].

2.5. **Justificativa para regulamentação local**

2.5.1. Diversos estudos nacionais evidenciam a urgência de regulamentar o ambiente alimentar escolar. Dois dos principais levantamentos, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2019)[3] e o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA, 2013-2014)[4], revelam um cenário alarmante de exposição de crianças e adolescentes a alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.

2.5.2. De acordo com a PeNSE, que entrevistou mais de 160 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental em 4.361 escolas públicas e privadas em todo o país, aproximadamente metade dos estudantes frequentava escolas com cantinas, e 79,4% tinham acesso a pontos de venda de alimentos nas imediações das instituições. A presença de cantinas era quase universal nas escolas privadas (96,2%), enquanto nas públicas atingia 27,9%. A oferta de refrigerantes alcançava cerca de 50% dos alunos nas cantinas e 78% quando considerados os pontos de venda alternativos[3].

2.5.3. O estudo ERICA, por sua vez, avaliou mais de 74 mil adolescentes de 12 a 17 anos, matriculados em escolas públicas e privadas de municípios com mais de 100 mil habitantes em todas as regiões do país. Os dados reforçam o diagnóstico de ambientes escolares marcados pela ampla disponibilidade de alimentos ultraprocessados: 75,2% das escolas privadas ofereciam refrigerantes, em comparação com 34,9% das públicas; 79,7% das privadas vendiam guloseimas, contra 35,7% das públicas; e máquinas de autoatendimento estavam presentes em 14,4% das escolas privadas e 5,5% das públicas[4].

2.5.4. Esses dados revelam a predominância de ambientes obesogênicos, especialmente nas escolas privadas, onde há menor regulação e fiscalização. A ampla disponibilidade e promoção de alimentos ultraprocessados contribui diretamente para a formação de hábitos alimentares inadequados desde a infância e adolescência, o que, por sua vez, está associado ao aumento dos índices de sobrepeso e obesidade entre os estudantes.

2.5.5. Além dos impactos sobre a saúde individual, o consumo de alimentos ultraprocessados impõe um ônus significativo ao sistema público. Estima-se que, apenas com bebidas ultraprocessadas, como refrigerantes, isotônicos e refrescos, os custos anuais para o Sistema Único de Saúde com o tratamento de doenças associadas alcancem aproximadamente R$ 3 bilhões[60].

2.5.6. De forma mais abrangente, estima-se que as doenças e mortes atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados resultem em um custo anual de R$ 10,4 bilhões para o setor público. Esse valor inclui tanto os custos diretos com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e medicamentos (cerca de R$ 933,5 milhões), quanto os custos indiretos relacionados à perda de produtividade econômica

por mortes prematuras, absenteísmo e benefícios previdenciários, que somam aproximadamente R$ 9,47 bilhões[61].

2.5.7. Projeções sobre os gastos federais com o tratamento de cânceres indicam que, em 2018, os custos relacionados ao excesso de peso alcançaram R$ 2,36 bilhões. Caso não sejam adotadas medidas de contenção, estima-se que esse valor possa crescer 140%, atingindo R$ 5,66 bilhões anuais até 2040. No mesmo período, os gastos com cânceres associados ao consumo de carnes processadas, que foram de R$ 545,22 milhões em 2018, podem aumentar 160%, chegando a R$ 1,42 bilhão por ano, caso os padrões atuais de consumo se mantenham[62].

2.5.8. Diante desse cenário, a regulamentação local do ambiente alimentar escolar é uma medida urgente e estratégica para proteger a saúde de crianças e adolescentes, prevenir doenças crônicas e reduzir os custos futuros para o setor público. Mais do que uma ação normativa, trata-se de um investimento essencial para romper com o ciclo intergeracional de adoecimento associado ao consumo de alimentos não saudáveis e para promover a formação de hábitos alimentares que perdurem ao longo da vida. Considerando que a escola é um dos espaços de proteção social mais relevantes para a promoção da alimentação adequada e saudável, por ser ambiente de convivência, aprendizado e construção de valores, regulamentá-lo representa uma oportunidade concreta de transformar o cotidiano das novas gerações, promovendo segurança alimentar e nutricional, equidade e bem-estar desde os primeiros anos de vida.

3. RECOMENDAÇÕES

3.1. Recomenda-se que os estados e municípios, especialmente aqueles que integram a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades – Alimenta Cidades, adotem medidas normativas e operacionais que assegurem a implementação local do Decreto nº 11.821/2023, com base nos seguintes passos:

I - Elaborar, aprovar e implementar legislação específica que regulamente a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, fundamentada nos princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos pelo Decreto;

II - Estabelecer mecanismos de fiscalização, monitoramento e avaliação da oferta, comercialização e doação de alimentos nas escolas públicas e privadas, com foco na promoção de alimentos in natura ou minimamente processados e de preparações culinárias feitas com esses alimentos, assegurando a vedação à oferta e comercialização de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar;

III - Instituir diretrizes para a regulação da comunicação mercadológica no ambiente escolar, com especial atenção à proteção de crianças e adolescentes contra práticas abusivas de publicidade de alimentos ultraprocessados;

IV - Incluir a educação alimentar e nutricional no currículo escolar e nas práticas pedagógicas, de forma transversal e contínua, conforme previsto na Lei nº 13.666/2018, promovendo ações intersetoriais com as áreas de assistência social, saúde, agricultura e meio ambiente;

V - Fortalecer a aquisição de alimentos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade brasileira, priorizando produtos locais, regionais e sustentáveis. Essa ação contribui para a valorização da cultura alimentar, o desenvolvimento territorial e a sustentabilidade dos sistemas alimentares;

VI - Promover ações de comunicação e mobilização social, com foco na valorização da alimentação adequada e saudável, na formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância e na conscientização da comunidade escolar sobre os impactos do consumo de alimentos ultraprocessados;

VII - Assegurar a participação social e a articulação intersetorial, por meio de instâncias como os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), Conselhos de Saúde, Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e Câmaras Intersetoriais de

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), garantindo a governança democrática da política alimentar escolar.

3.2. O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), informa que está em curso uma ação coordenada para apoiar à implementação do Decreto. O apoio oferecido visa contribuir com estados e municípios na estruturação de normativas locais que fortaleçam o ambiente alimentar escolar, promovam a segurança alimentar e nutricional e previnam o sobrepeso, a obesidade e as doenças crônicas relacionadas à má-nutrição.

3.3. A implementação do Decreto é uma das prioridades da SESAN/MDS e está inserida no escopo da Estratégia Alimenta Cidades, especialmente no Eixo III, que trata da promoção de ambientes alimentares urbanos saudáveis. Essa Estratégia busca fortalecer a agenda alimentar urbana, ampliando o acesso, a produção e o consumo de alimentos saudáveis, com foco em territórios periféricos e populações em situação de vulnerabilidade.

3.4. A SESAN/MDS tem atuado em diversos estados e municípios, com o apoio da COSAN/FNDE e em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, para oferecer assessoramento técnico individualizado ou coletivo, conforme o estágio de regulamentação local. Essa atuação também conta com apoiadores(as) locais em campo, que colaboram diretamente com as gestões estaduais e municipais, inclusive por meio do fortalecimento da governança intersetorial nas Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional, espaços essenciais para o diálogo entre setores, definição de prioridades locais e coordenação de ações integradas.

4. CONCLUSÃO

4.1. A regulamentação local da promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar é uma medida estratégica e urgente para enfrentar os desafios sociais, sanitários e ambientais associados aos atuais padrões alimentares. Ao consolidar as escolas como espaços promotores da segurança alimentar e nutricional, da saúde e da cidadania, os entes federativos contribuem diretamente para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes e para a construção de um futuro mais justo, saudável e sustentável.

4.2. A adoção de legislações estaduais e municipais alinhadas ao Decreto fortalece a capacidade institucional de transformar o ambiente alimentar escolar, promovendo escolhas mais saudáveis, reduzindo desigualdades e prevenindo DCNT desde a infância. Trata-se de uma ação de responsabilidade compartilhada, que exige articulação intersetorial, participação social e compromisso político.

4.3. Diversos entes federativos já vêm avançando nesse processo. A cidade de Paulista/PE e o estado do Maranhão, por exemplo, já aprovaram legislações específicas e se encontram em fase de regulamentação. Esses exemplos demonstram que o esforço é coletivo e crescente: estados e municípios têm compreendido seu papel na regulação do ambiente escolar e mobilizado esforços entre os poderes Executivo, Legislativo e sociedade civil para catalisar essas medidas. Em nível federal, também tramitam projetos de lei que buscam estabelecer diretrizes nacionais para a promoção de ambientes escolares mais saudáveis, reforçando a importância e a urgência do tema.

4.4. O MDS, por meio da Coordenação-Geral de Promoção da Alimentação Saudável (CGSAU), vinculada ao Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (DESAU) da SESAN, reafirma seu compromisso com o apoio técnico aos entes federativos, colocando-se à disposição para colaborar na elaboração, implementação e monitoramento de normativas locais.

4.5. Para esclarecimentos adicionais, a CGSAU pode ser contatada pelo endereço eletrônico: cgsau@mds.gov.br.

5. REFERÊNCIAS

[1]STALLINGS, V. A. et al. Nutrition standards for foods in schools: leading the way toward healthier youth. Washington, DC: National Academies Press, 2007.

[2]O'TOOLE, T. P. et al. Nutrition services and foods and beverages available at school: results from the School Health Policies and Programs Study 2006. Journal of School Health, v. 77, n. 8, p. 500–521, 2007.

[3]INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa nacional de saúde do escolar: análise de indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. 74–75 p.

[4]CARMO, A. S. et al. The food environment of Brazilian public and private schools. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, n. 12, e00014918, 2018.

[5]BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed., 1. reimpr. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

[6]BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019.

[7]MONTEIRO, C. A. et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutrition, v. 22, n. 5, p. 936–941, 2019.

[8]MONTEIRO, C. A. et al. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. Rome: FAO, 2019.

[9]BARBARESKO, J. et al. Ultra-processed food consumption and human health: an umbrella review of systematic reviews with meta-analyses. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, p. 1–9, 2024.

[10]LANE, M. M. et al. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ, v. 384, e077310, 2024.

[11]THE LANCET DIABETES ENDOCRINOLOGY. Ultra-processed foods: yet another wake-up call. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 13, n. 6, p. 453, 2025.

[12]HIGH LEVEL PANEL OF EXPERTS (HLPE). La nutrición y los sistemas alimentarios. Roma: HLPE, 2017.

[13]SWINBURN, B. A. et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. The Lancet, v. 393, n. 10173, p. 791–846, 2019.

[14]BURIGO, A. C.; PORTO, M. F. 2030 Agenda, health and food systems in times of syndemics: from vulnerabilities to necessary changes. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 10, p. 4411–4424, 2021.

[15]FAO; FIDA; OMS; PMA; UNICEF. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Roma: FAO, 2023.

[16]PINEDA, A. M. R. et al. Da produção aos impactos na saúde e no ambiente: uma análise dos sistemas alimentares de Brasil, Colômbia e Panamá. Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 4, p. 1101–1112, 2023.

[17]FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Influencing food environments for healthy diets. Rome: FAO, 2016.

[18]FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Global food policy report 2024: food systems for healthy diets and nutrition. Rome: FAO; IFPRI, 2024.

[19]BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 11.821, de 12 de dezembro de 2023. Dispõe sobre os princípios, os objetivos, os eixos estratégicos e as diretrizes que orientam as ações de

promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.

[20]BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Ações de enfrentamento da má nutrição no contexto da pandemia: Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021 – Capítulo III. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

[21]DIAS, P. C. et al. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, n. 7, e00006016, 2017.

[22]POPKIN, B. M.; CORVALAN, C.; GRUMMER-STRAWN, L. M. Dynamics of the double burden of malnutrition and the changing nutrition reality. The Lancet, v. 395, n. 10217, p. 65–74, 2020.

[23]SANTANA, D. D. et al. Mudanças na prevalência de excesso de peso em adolescentes residentes em área de alta vulnerabilidade à insegurança alimentar. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 12, p. 6189–6198, 2021.

[24]MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISVAN [internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/. Acesso em: 11 set. 2023.

[25]BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2023: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

[26]NCD RISK FACTOR COLLABORATION (NCD-RisC). Global, regional, and national prevalence of child and adolescent overweight and obesity, 1990–2022, with forecasts to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2022. The Lancet, v. 403, n. 10431, p. 1030–1048, 2024.

[27]WORLD OBESITY FEDERATION. Atlas Mundial da Obesidade 2024. Tradução e adaptação: Painel Brasileiro da Obesidade (PBO)/Instituto Cordial. Fórum DCNTs, 2024.

[28]WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: WHO, 2000.

[29]WORLD HEALTH ORGANIZATION. Noncommunicable diseases country profiles 2018. Geneva: WHO, 2018.

[30]WORLD HEALTH ORGANIZATION. World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: WHO, 2023.

[31]BRASIL. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021–2030. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

[32]BRASIL. Sistema de Informação sobre Mortalidade. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

[33]LEVY, R. B. et al. Three decades of household food availability according to NOVA – Brazil, 1987–2018. Revista de Saúde Pública, v. 56, p. 75, 2022.

[34]LOUZADA, M. L. D. C. et al. Consumption of ultra-processed foods in Brazil: distribution and temporal evolution 2008–2018. Revista de Saúde Pública, v. 57, p. 12, 2023.

[35]UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). Alimentação Infantil II: consumo alimentar de crianças menores de 5 anos: ENANI 2019. Rio de Janeiro: UFRJ, 2024.

[36]BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN: estado nutricional dos beneficiários do Programa Bolsa Família. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

[37]WORLD CANCER RESEARCH FUND. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. In: RESEARCH, A. I. F. C. (ed.). 2018.

[38]INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

[39]LOUZADA, M. L. D. C. et al. Changes in obesity prevalence attributable to ultra-processed food consumption in Brazil between 2002 and 2009. International Journal of Public Health, v. 67, p. 1604103, 2022.

[40]NILSON, E. A. F. et al. Premature deaths attributable to the consumption of ultraprocessed foods in Brazil. American Journal of Preventive Medicine, v. 64, n. 1, p. 129–136, 2023.

[41]NILSON, E. A. F. et al. The estimated burden of ultra-processed foods on cardiovascular disease outcomes in Brazil: a modeling study. Frontiers in Nutrition, v. 9, 1043620, 2022.

[42]CASCAES, A. M. et al. Ultra-processed food consumption and dental caries in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Nutritional, v. 129, n. 8, p. 1370-1379, 2022.

[43]PETRIDI, E. et al. The impact of ultra-processed foods on obesity and cardiometabolic comorbidities in children and adolescents: a systematic review. Nutrition Reviews, v. 82, n. 7, p. 913–928, 2024.

[44]DA CRUZ, G. L. et al. The environmental impact of beef and ultra-processed food consumption in Brazil. Public Health Nutrition, v. 27, n. 1, p. e34, 2024.

[45]GARZILLO, J. M. F. et al. Ultra-processed food intake and diet carbon and water footprints: a national study in Brazil. Revista de Saúde Pública, v. 56, p. 6, 2022.

[46]GARZILLO, J. M. F. et al. Pegada de carbono da dieta no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 55, p. 90, 2021.

[47]DA SILVA, J. T. et al. Greenhouse gas emissions, water footprint, and ecological footprint of food purchases according to their degree of processing in Brazilian metropolitan areas: a time-series study from 1987 to 2018. The Lancet Planetary Health, v. 5, n. 11, p. e775–e785, 2021.

[48]BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

[49]BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

[50]BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 jun. 2009.

[51]BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 set. 1990.

[52]BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resolução nº 163, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 abr. 2014.

[53]BRASIL. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 maio 2018.

[54]UNITED NATIONS (UN). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UN, 2015. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals. Acesso em: 18 jul. 2025.

[55]UNITED NATIONS (UN). United Nations Decade of Action on Nutrition 2016–2025. Geneva: UN, 2016. Disponível em: https://www.un.org/nutrition/decade-of-action. Acesso em: 18 jul. 2025.

[56]UNITED NATIONS (UN). UN Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment. Rome: UN, 2023. Disponível em: https://www.un.org/en/food-systems-summit. Acesso em: 18 jul. 2025.

[57]BRASIL. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. III Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2025–2027). Brasília, DF: Governo Federal, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/caisan/iii_plansan.pdf. Acesso em: 18 jul. 2025.

[58]BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Sumário executivo: Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2023/2026. Versão 4, atualizado em jul. 2025. Brasília, DF: MDS, 2025.

[59]BRASIL. Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Ministério da Saúde; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Acordo de Cooperação Técnica nº 5/2023: promoção da alimentação saudável e fortalecimento da agricultura familiar no ambiente escolar. Brasília, DF: MEC, MDA, MDS, MS, FNDE, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/acordo-de-cooperacao-tecnica/2023/act-05-2023.pdf. Acesso em: 23 jul. 2025.

[60]ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE. O lado oculto das bebidas açucaradas: doenças, mortes e custos para o Sistema Único de Saúde. São Paulo: ACT Promoção da Saúde, 2021.

[61]ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE. Relatório 2: estimação dos custos diretos e indiretos da obesidade, diabetes e hipertensão atribuíveis ao consumo de produtos alimentícios ultraprocessados na população adulta do Brasil. In: FIOCRUZ; ENFOC. São Paulo: ACT Promoção da Saúde, 2024.

[62]INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Gastos federais atuais e futuros com os cânceres atribuíveis aos fatores de risco relacionados à alimentação, nutrição e atividade física no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022.

Atenciosamente,

Gisele Ane Bortolini
Coordenadora-Geral de Promoção da Alimentação Saudável

De acordo,

Patrícia Chaves Gentil
Diretora de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável

Documento assinado eletronicamente por **Gisele Ane Bortolini**, **Coordenador(a)-Geral**, em 11/09/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Chaves Gentil**, **Diretor(a) do Departamento de Promoção de Alimentação Adequada e Saudável**, em 12/09/2025, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador **17468279** e o código CRC **EE1E9589**.

Referência: Processo nº 71000.091375/2025-85 SEI nº 17468279